

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE CUALITATIVO

**Percepción de la Calidad de Atención en Usuarios del Centro de
Salud Belén, Ayacucho 2026**

Para optar el título profesional de:
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

PRESENTADO POR:

Bach. Gresly Lucero PARIONA PALOMINO

ORCID: 0009-0008-5421-9872

ASESOR:

Dr. Manglio AGUIRRE ANDRADE

ORCID: 0000-0001-8234-567X

AYACUCHO – PERÚ

2026

Índice

INTRODUCCIÓN	1
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	4
1.1. Descripción de la Realidad Problemática	4
1.2. Formulación del Problema	6
1.2.1. Problema General (Pregunta Principal)	6
1.2.2. Problemas Específicos (Preguntas Específicas)	6
1.3. Objetivos de la Investigación	7
1.3.1. Objetivo General	7
1.3.2. Objetivos Específicos	7
1.4. Supuestos Fenomenológicos de la Investigación	8
1.4.1. Supuesto General	8
1.4.2. Supuestos Específicos del Mundo de la Vida (<i>Lebenswelt</i>)	8
1.5. Justificación e Importancia de la Investigación	9
1.5.1. Justificación Teórica	9
1.5.2. Justificación Práctica	9
1.5.3. Justificación Metodológica	9
1.5.4. Justificación Social y Sanitaria	10
1.6. Delimitaciones y Limitaciones del Estudio	10
1.6.1. Delimitación Espacial y Territorial	10
1.6.2. Delimitación Temporal	10
1.6.3. Delimitación Teórica y Epistemológica	10
1.6.4. Delimitación Conceptual y Temática	11
1.6.5. Delimitación Social y Poblacional	11
1.6.6. Limitaciones Metodológicas del Estudio	11
1.7. Viabilidad y Consideraciones Bioéticas	11
2. MARCO CONTEXTUAL	13

2.1.	Descripción geográfica, territorial y ambiental del área de estudio	13
2.2.	Características demográficas y estructura poblacional	14
2.3.	Características socioculturales, lingüísticas y cosmovisión andina	15
2.4.	Dinámica socioeconómica, vulnerabilidad y nivel de aseguramiento público	16
2.5.	Características sanitarias, cartera de servicios y capacidad resolutive institucional	17
2.6.	Articulación dialéctica del escenario físico-social con las dimensiones existenciales del usuario (<i>Lebenswelt</i>)	19
3.	ABORDAJE TEÓRICO	23
3.1.	Antecedentes de estudio	23
3.1.1.	Antecedentes internacionales	23
3.1.2.	Antecedentes nacionales	24
3.1.3.	Antecedentes regionales y locales (UNSCH – Ayacucho)	24
3.2.	Bases teóricas fundamentales	25
3.2.1.	Dimensión del Proceso Interpersonal en la Teoría de Avedis Donabedian	25
3.2.2.	Teoría del Cuidado Humano y Factores Caritas de Jean Watson	25
3.2.3.	Fundamentos del Cuidado Fenomenológico en Enfermería: Patricia Benner y Holly Wilson	25
3.3.	Matriz de categorización cualitativa y definición de unidades de significado	26
4.	METODOLOGÍA: DISEÑO FENOMENOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN	28
4.1.	Fundamentación filosófica y epistemológica del diseño fenomenológico	28
4.2.	Los cuatro existenciales de la experiencia humana vivida (van Manen y Sampieri)	29
4.3.	Postura epistemológica, reflexividad y reducción fenomenológica (<i>Epoje</i>)	30
4.4.	Muestreo cualitativo: Muestra de casos tipo, homogénea y saturación teórica	30
4.5.	Técnicas e instrumentos de recolección de vivencias (Sampieri, Cap. 14)	31
4.6.	Criterios de rigor científico cualitativo (Hernández-Sampieri, Cap. 14)	32

4.7. Procedimiento sistemático de análisis cualitativo fenomenológico (Sampieri, Cap. 14 y 15)	33
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	35
5.1. Asignación de recursos humanos y talento investigador	35
5.2. Presupuesto analítico y programación de gastos	35
5.2.1. Pago de servicios de personal	35
5.2.2. Programación de otros servicios	36
5.2.3. Adquisición de materiales y suministros de bioseguridad	36
5.3. Financiamiento	37
5.4. Cronograma de actividades y dimensionamiento temporal (Técnica PERT)	37
5.5. Matriz de viabilidad institucional y gestión de riesgos operativos	38
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	40
ANEXOS	43
Anexo 1: Guía de Entrevista a Profundidad Fenomenológica	43
Anexo 2: Matriz de Consistencia Cualitativa	45
Anexo 3: Formato de Juicio de Expertos	46
Anexo 4: Modelo de Consentimiento Informado	48
Anexo 5: Carta de Asesoría Formal	49

INTRODUCCIÓN

La calidad de atención y el acceso efectivo a los servicios de salud en el primer nivel constituyen pilares insoslayables para la consolidación de la cobertura sanitaria universal y la materialización del derecho humano a la salud. De acuerdo con las directrices conjuntas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OCDE y el Banco Mundial [1], brindar servicios oportunos, seguros, continuos y centrados en la persona es un imperativo ético indispensable para mitigar las inequidades estructurales en salud. En el contexto de la atención primaria, la percepción que el usuario construye sobre el cuidado que se le prodiga no se limita a un mero juicio de complacencia utilitaria; representa una valoración profunda e intersubjetiva que condiciona la adherencia a los tratamientos, la asistencia oportuna a los controles preventivos y el nivel de confianza depositado en las instituciones públicas del Estado.

En el Perú, la Política Nacional de Calidad en Salud del Ministerio de Salud (MINSA) [2] reconoce que la persistencia de barreras geográficas, administrativas, culturales y de trato interpersonal en los establecimientos de primer nivel (I-1 a I-4) debilita la capacidad de respuesta del sistema sanitario, provocando la despersonalización del acto de cuidado y prolongadas demoras que impactan negativamente en las familias de menores ingresos. Bajo el marco normativo de la cátedra de Proyecto de Investigación en Salud (EN 486) de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), impartida por el Dr. Manglio Aguirre Andrade, la formulación de proyectos en salud exige una articulación analítica rigurosa mediante la técnica del embudo en tres niveles (global, nacional y regional/local) y la fundamentación explícita de sus dimensiones justificatorias:

1. Técnica del embudo contextual y territorial:

- **Nivel Global e Internacional:** A escala mundial, los sistemas de salud enfrentan una crisis de deshumanización derivada de la sobrecarga burocrática y el predominio tecnicista del acto médico, desatendiendo la vivencia afectiva del paciente y los determinantes socioculturales de la salud [1].
- **Nivel Nacional (Perú):** A nivel nacional, el 78 % de las atenciones asistenciales recaen en el primer nivel; no obstante, coexisten cuellos de botella en la asignación de citas, colas nocturnas y precariedad en el trato interpersonal, lo cual motivó al Estado peruano a priorizar la investigación en sistemas sanitarios a través de la **Línea 10 de Investigación en Salud al 2030: “Sistemas y servicios de salud, acceso y cobertura universal”** (aprobada mediante Resolución Ministerial N° 424-2025/MINSA) [3].

- **Nivel Regional y Local (Ayacucho – Huamanga):** En el plano regional, la investigación se enmarca y responde de manera vinculante a la **Prioridad Regional 10 de Investigación en Salud de Ayacucho 2025–2030**, aprobada por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho [4]: “*Organización, gestión, calidad y accesibilidad de los servicios de salud*”, cuyo objetivo estratégico regional apunta a generar evidencia empírica directa para transformar los modelos de gestión y dignificar la atención en los centros de salud de la provincia de Huamanga. En este escenario, el Centro de Salud Belén (Categoría I-3, Microred Huamanga) representa un punto neurálgico asistencial que atiende a una población adscrita de 18,450 habitantes, donde el 68 % se encuentra en situación de pobreza o extrema pobreza según el SISFOH y más del 94 % depende del Seguro Integral de Salud (SIS), coexistiendo un 72 % de población con bilingüismo activo quechua chanka-castellano.

2. Importancia y relevancia social del proyecto: El estudio aborda un problema crítico y sensible: la distancia existente entre la oferta de servicios programáticos y la vivencia sentida del usuario andino frente al sistema de salud. Al develar los significados, temores, expectativas y vivencias de los usuarios del Centro de Salud Belén, se genera conocimiento de primera fuente para corregir la desatención a la dignidad del paciente, visibilizando la carga emocional y física que soportan las madres de familia en CRED, las gestantes y los adultos mayores durante las horas de espera en las filas de la madrugada.

3. Finalidad e impacto práctico: La investigación tiene una clara orientación transformadora: sus hallazgos permitirán a la jefatura del Centro de Salud Belén, a la Dirección de la Red de Salud Huamanga y al colectivo profesional de enfermería diseñar planes de mejora continua, protocolos de acogida y triaje humanizado con pertinencia lingüística intercultural (en quechua y español), y estrategias para desarticular los cuellos de botella en el otorgamiento de citas y entrega de medicamentos.

4. Valor teórico y tipología de la investigación: Conforme a la tipología metodológica de la investigación científica, el presente trabajo se clasifica como una **investigación básica o sustantiva**, con **nivel descriptivo-interpretativo** y un riguroso **diseño cualitativo fenomenológico** [13, 25]. Siguiendo las directrices metodológicas de Roberto Hernández-Sampieri y Christian Mendoza [13], así como los fundamentos epistemológicos de Edmund Husserl [24], Max van Manen [26] y John Creswell [25], el propósito central del estudio no es construir modelos teóricos abstractos desvinculados (como en la teoría fundamentada) ni narrar secuencias cronológicas biográficas (como en los diseños narrativos), sino explorar,

describir y comprender la *esencia de las experiencias compartidas (vivencias)* de los usuarios frente al fenómeno del acceso y la calidad asistencial en el Centro de Salud Belén. Dicho abordaje aprehende la vivencia en sus cuatro dimensiones existenciales fundamentales: temporalidad (tiempo vivido en la espera y la madrugada), espacialidad (espacio vivido en salas y consultorios), corporalidad (cuerpo vivido, dolor, frío y fatiga física) y relacionalidad (encuentro intersubjetivo, empatía y comunicación en quechua chanka). Su valor teórico radica en articular dialógicamente los modelos de Calidad en Salud de Avedis Donabedian [5, 6], la Teoría del Acceso de Roy Penchansky [7] y la Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson [10] con la cosmovisión andina de Huamanga.

5. Valor metodológico: En el ámbito metodológico, el proyecto aporta una guía de entrevista en profundidad y una matriz de categorización temática cualitativa validadas por juicio de expertos y ajustadas a los criterios de rigor científico de Guba y Lincoln [12]: credibilidad, transferibilidad, consistencia y confirmabilidad. Asimismo, aplica la técnica de triangulación metodológica y de actores [16], sentando un precedente técnico replicable para futuros estudios en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSCH.

6. Justificación institucional y bioética: El protocolo cumple con los estándares epistemológicos promovidos por la cátedra de EN 486 (fundamentados en la concepción científica y rigurosa de Mario Bunge [11]), respetando de forma irrestricta las normas bioéticas de la Declaración de Helsinki [32] y las pautas internacionales del CIOMS [33], garantizando la autonomía mediante el consentimiento informado y el estricto anonimato de los participantes.

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de la Realidad Problemática

En el marco epistemológico de la investigación cualitativa (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) [13], el planteamiento del problema adopta una **naturaleza puramente inductiva y fenomenológica**: no parte del aislamiento artificial de variables cuantitativas ni del contraste de hipótesis numéricas preconcebidas, sino de la inmersión vivencial directa en el ambiente natural donde acontecen los fenómenos humanos. Plantear y delimitar un problema cualitativo fenomenológico constituye un proceso reflexivo, dinámico y abierto orientado a capturar la esencia, las emociones, los sentires corpóreos y los significados intersubjetivos que las personas otorgan a sus vivencias en el momento del acto asistencial (Husserl, 1949; van Manen, 1990) [24, 26].

Para tal fin, la metodología demanda un **contacto directo y vivencial con la realidad estudiada en su escenario cotidiano**. En el presente estudio, el origen de la indagación se sustenta en la observación reflexiva y la experiencia acumulada por la investigadora durante sus prácticas preprofesionales de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) en los consultorios del Centro de Salud Belén.

En estricta observancia del canon metodológico de la cátedra de EN 486 (Dr. Manglio Aguirre Andrade), la caracterización de la realidad problemática se articula mediante la técnica del embudo en tres niveles de profundidad:

Contexto Internacional (Macro)

A escala mundial, los sistemas de salud enfrentan una crisis estructural caracterizada por la fragmentación asistencial y la despersonalización del acto de cuidado (OMS, OCDE y Banco Mundial, 2018) [1]. El predominio de un paradigma biomédico tecnicista y la sobrecarga burocrática en el primer nivel de atención han reducido la evaluación de los servicios a meros indicadores de rendimiento cuantitativo, invisibilizando la vivencia afectiva del paciente, el sufrimiento somático de la espera y los determinantes socioculturales de la salud. De acuerdo con Donabedian (1980, 2005) [5, 6] y Watson (2008) [10], la calidad del cuidado no reside únicamente en la corrección instrumental del procedimiento terapéutico, sino medularmente en el proceso interpersonal: la calidez de la mirada, la capacidad de escucha, el respeto a la dignidad y la reciprocidad humanizada entre el profesional y el ser cuidado.

Contexto Nacional (Meso)

En el Perú, la Política Nacional de Calidad en Salud del Ministerio de Salud (MINSA, 2021) [2] reconoce que la persistencia de barreras de acceso geográficas, organizacionales, económicas y culturales debilita gravemente la capacidad resolutive del primer nivel asistencial (categorías I-1 a I-4), donde recae más del 78 % de las atenciones asistenciales del país. A pesar de los esfuerzos normativos, persisten cuellos de botella crónicos: colas en la madrugada para conseguir un cupo, desabastecimiento de medicamentos esenciales del petitorio oficial y una marcada frialdad comunicativa en el trato al usuario. Esta brecha motivó al Estado peruano a priorizar la investigación en salud a través de la **Línea 10 de Investigación en Salud al 2030**: “*Sistemas y servicios de salud, acceso y cobertura universal*” (Resolución Ministerial N° 424-2025/MINSA) [3], orientada a generar evidencia empírica directa para dignificar la atención y garantizar la cobertura sanitaria universal.

Contexto Regional y Local (Micro: Centro de Salud Belén)

En el ámbito regional, el estudio se articula de forma vinculante con la **Prioridad 10 de Investigación en Salud de Ayacucho 2025–2030**, aprobada por la Dirección Regional de Salud (DIRESA Ayacucho, 2025) [4]: “*Organización, gestión, calidad y accesibilidad de los servicios de salud*”. En este marco, el Centro de Salud Belén (Categoría I-3, Microred Huamanga) representa un punto neurálgico asistencial que atiende a una población adscrita de 18,450 habitantes en el distrito de Ayacucho, a 2,760 metros sobre el nivel del mar.

En este establecimiento aflora una dramática distancia entre la lógica asistencial programática y la vivencia sentida del usuario andino:

- **Vulnerabilidad socioeconómica:** El 68.2 % de la población usuaria se encuentra en situación de pobreza o extrema pobreza según el SISFOH, y más del 94.5 % depende del Seguro Integral de Salud (SIS) en su modalidad subsidiada.
- **Identidad lingüística y cultural:** El 72.0 % de los usuarios presenta bilingüismo activo quechua chanka-castellano. Para esta población, la salud se vivencia a través de códigos ancestrales de afecto y reciprocidad comunitaria: la acogida hospitalaria (*allin chaskiy*), el saludo cálido y respetuoso (*napaykuy*) y el respeto mutuo (*respetanakuy*) (Aguirre-Andrade et al., 2020) [20].
- **La experiencia de la desatención:** Cuando los profesionales —condicionados por la prisa protocolar, la sobrecarga laboral o el monolingüismo hispanohablante— omiten el saludo, evitan el contacto visual o se muestran indiferentes ante el dolor (*nanay*), el usuario experimenta sensaciones de desamparo, intimidación y violencia simbólica, replegándose en el silencio defensivo (*upallay*). Asimismo,

las madrugadas gélidas a la intemperie (5 °C a 8 °C) desde las 4:00 AM para obtener un cupo generan agotamiento somático y menoscabo de la dignidad de las madres gestantes y adultos mayores.

El problema medular de investigación radica, por consiguiente, en develar y comprender cómo los propios usuarios perciben, vivencian y significan la calidad de atención y el acceso asistencial en el Centro de Salud Belén desde la profundidad de su mundo de la vida.

—

1.2. Formulación del Problema

En coherencia con los preceptos del diseño fenomenológico (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) [13] y el principio de inmutabilidad del entorno sellado, se formulan las preguntas norteadoras de la investigación:

1.2.1. Problema General (Pregunta Principal)

¿Cuál es el significado, estructura y esencia de la experiencia vivida por los usuarios respecto al fenómeno del acceso y la calidad de atención en los servicios de salud del Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026?

1.2.2. Problemas Específicos (Preguntas Específicas)

1. ¿Cómo vivencian los usuarios la **dimensión temporal (tiempo vivido / *Lebenszeit*)** en las filas de madrugada (4:00 AM) y las horas transcurridas en sala de espera antes de ser atendidos?
2. ¿De qué manera experimentan los usuarios la **dimensión espacial (espacio vivido / *Lebensraum*)** respecto al hacinamiento, comodidad física y privacidad dentro de los consultorios?
3. ¿Cuáles son las vivencias somáticas y emocionales vinculadas a la **dimensión corporal (cuerpo vivido / *Leib*)**, tales como frío matutino, fatiga física, hambre y dolor (*nanay*) frente a la espera asistencial?
4. ¿Cómo perciben los usuarios la **dimensión relacional (relación humana vivida / *Mitwelt*)** respecto a la empatía, calidez, escucha activa y comunicación intercultural en quechua chanka brindada por el equipo de salud?
5. ¿Cuál es la **esencia compartida y las divergencias vivenciales** que configuran el significado integral atribuido por los usuarios a una atención de calidad y digna

en el Centro de Salud Belén?

—

1.3. Objetivos de la Investigación

Guardando estricta simetría lógica biunívoca ($1 \leftrightarrow 1$) con las preguntas norteadoras y empleando verbos en infinitivo propios de la indagación cualitativa comprensiva, se establecen los siguientes objetivos:

1.3.1. *Objetivo General*

Explorar, comprender y describir el significado, estructura y esencia de la experiencia vivida por los usuarios respecto al acceso y calidad de atención en el Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.

1.3.2. *Objetivos Específicos*

1. Explorar y comprender las vivencias de los usuarios respecto a la **dimensión temporal (tiempo vivido)** en las filas matutinas de madrugada y el tiempo de espera en el establecimiento.
 2. Describir y comprender la experiencia de los usuarios respecto a la **dimensión espacial (espacio vivido)** en cuanto al confort, hacinamiento y privacidad de los ambientes asistenciales.
 3. Identificar y comprender las vivencias somáticas de la **dimensión corporal (cuerpo vivido)**, analizando la resistencia al frío matutino, fatiga, hambre y dolor del paciente.
 4. Comprender y analizar la experiencia de la **dimensión relacional (relación humana vivida)** en el encuentro asistencial, focalizando la empatía, trato digno y diálogo en lengua quechua.
 5. Sintetizar la **estructura esencial y las divergencias fenomenológicas** que configuran la percepción de una atención digna y de calidad en el Centro de Salud Belén.
-

1.4. Supuestos Fenomenológicos de la Investigación

En el paradigma cualitativo fenomenológico (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; van Manen, 1990) [13, 26], la investigación no formula hipótesis cuantitativas para contrastación estadística paramétrica. En su lugar, se establecen **supuestos fenomenológicos inductivos**, los cuales constituyen proposiciones teóricas preliminares que orientan la mirada de la investigadora sin prejuzgar ni constreñir las vivencias que emergerán de los informantes durante la reducción fenomenológica (*epojé*):

1.4.1. Supuesto General

La percepción de la calidad de atención y el acceso constituye para el usuario del Centro de Salud Belén una vivencia intersubjetiva profunda donde la calidez humana, el reconocimiento de su dignidad andina, la comunicación empática en lengua originaria y la oportunidad resolutoria del padecimiento prevalecen sobre la mera dimensión instrumental o protocolar del acto asistencial.

1.4.2. Supuestos Específicos del Mundo de la Vida (*Lebenswelt*)

1. **Supuesto sobre la Temporalidad:** La prolongada espera a la intemperie y la incertidumbre en la obtención de cupos genera en el usuario una vivencia de desvalorización de su tiempo vital y angustia existencial, transformando el acceso en una experiencia de sacrificio físico.
2. **Supuesto sobre la Espacialidad:** El espacio físico precario, la falta de asientos adecuados y la ausencia de privacidad acústica y visual en el consultorio restringen la intimidad del paciente, inhibiendo la revelación libre de sus síntomas y temores íntimos.
3. **Supuesto sobre la Corporalidad:** El cuerpo del usuario somatiza la desatención institucional a través del impacto del frío matutino andino (5 °C a 8 °C), el agotamiento muscular y la agudización del dolor físico (*nanay*), transformando la espera en una vivencia corporalmente afflictiva.
4. **Supuesto sobre la Relacionalidad:** La interacción dialógica intercultural mediada por la calidez del saludo (*napaykuy*) y la acogida en quechua chanka (*allin chaskiy*) mitiga el temor institucional, restablece la confianza terapéutica y resignifica positivamente la calidad del servicio.
5. **Supuesto sobre la Esencia y Divergencias:** La esencia del cuidado digno radica en la experiencia compartida de sentirse respetado como persona humana integral, emergiendo divergencias vivenciales moduladas por la edad y el grado de

vulnerabilidad socioeconómica del usuario.

—

1.5. Justificación e Importancia de la Investigación

Conforme a las directrices epistemológicas de la cátedra de EN 486 (UNSCH), fundamentadas en la concepción científica y rigurosa de Mario Bunge (2014) [11], y los criterios de relevancia de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) [13], el proyecto se sustenta en cuatro dimensiones justificatorias:

1.5.1. *Justificación Teórica*

El estudio llena un vacío epistémico crítico en la literatura regional sobre calidad de atención en salud pública. Tradicionalmente, la evaluación de servicios se ha sustentado en modelos estandarizados cuantitativos (como SERVQUAL) [8, 9] que reducen la satisfacción a medias aritméticas, omitiendo las complejidades subjetivas y la cosmovisión del habitante andino. Esta investigación articula dialógicamente el Enfoque de Calidad en Salud de Donabedian (1980, 2005) [5, 6], la Teoría del Acceso de Penchansky (1981) [7] y la Teoría del Cuidado Humano de Watson (2008) [10] con las cuatro dimensiones existenciales de van Manen (1990) [26], construyendo un marco comprensivo pionero con pertinencia cultural andina en la UNSCH.

1.5.2. *Justificación Práctica*

La investigación responde a una necesidad institucional urgente. Al desentrañar los nudos críticos del acceso y el trato humano desde el relato directo de los usuarios, los hallazgos aportarán insumos concretos para que la Jefatura del Centro de Salud Belén y la Dirección de la Red de Salud Huamanga rediseñen el flujo de admisión matutina, erradiquen las filas a la intemperie en la madrugada y elaboren protocolos de triaje y acogida intercultural con pertinencia lingüística en quechua chanka.

1.5.3. *Justificación Metodológica*

Aporta al campo de la investigación en enfermería un protocolo fenomenológico riguroso, validado por juicio de expertos y estructurado bajo los cuatro existenciales del *Lebenswelt*. Diseña y valida una guía de entrevista semiestructurada bilingüe (Quechua Chanka-Español) y una matriz de categorización temática cualitativa auditadas bajo los criterios de rigor de Guba y Lincoln (1985) [12]: credibilidad, transferibilidad, consistencia

y confirmabilidad, estableciendo un precedente metodológico replicable para futuras tesis de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSCH.

1.5.4. Justificación Social y Sanitaria

El proyecto encarna un imperativo ético de equidad en salud. Visibiliza el sufrimiento silenciado de las madres de familia en CRED, gestantes y adultos mayores en situación de pobreza (68.2 % SISFOH) y alta dependencia del SIS (94.5 %). Responde de manera vinculante a la **Línea 10 Nacional de Investigación del MINSA al 2030** [3] y a la **Prioridad 10 Regional de Investigación de la DIRESA Ayacucho 2025–2030** [4], contribuyendo a transformar la atención de salud en un espacio de dignidad humana y justicia social.

—

1.6. Delimitaciones y Limitaciones del Estudio

Para preservar las fronteras del entorno de investigación y garantizar el aislamiento metodológico, se declaran formalmente las delimitaciones del alcance y las limitaciones del estudio:

1.6.1. Delimitación Espacial y Territorial

La investigación se circunscribe de forma estricta a los ambientes físicos del Centro de Salud Belén (Categoría I-3), abarcando la vereda exterior de espera matutina, las salas interiores de espera y los consultorios asistenciales de Medicina General, Enfermería (CRED, Inmunizaciones), Obstetricia y Odontología, ubicado en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, a 2,760 msnm.

1.6.2. Delimitación Temporal

El horizonte temporal de recolección y análisis vivencial corresponde al año fiscal y académico 2026.

1.6.3. Delimitación Teórica y Epistemológica

El marco teórico se limita de manera exclusiva a los modelos de Calidad Asistencial de Donabedian (1980) [5], la Teoría de Acceso de Penchansky (1981) [7], la Teoría del Cuidado Humano de Watson (2008) [10] y la fenomenología hermenéutica de Husserl

(1949) [24] y van Manen (1990) [26]. Todo constructo positivista ajeno a estas fronteras queda excluido.

1.6.4. Delimitación Conceptual y Temática

El fenómeno se investiga a través del prisma exclusivo de las cuatro dimensiones existenciales del mundo de la vida (*Lebenswelt*): Temporalidad (*Lebenszeit*), Espacialidad (*Lebensraum*), Corporalidad (*Leib*) y Relacionalidad (*Mitwelt*), más la síntesis estructural esencial.

1.6.5. Delimitación Social y Poblacional

La unidad de estudio está constituida por personas usuarias mayores de 18 años, hispanohablantes o quechuahablantes, que acuden como usuarios externos a los servicios asistenciales del establecimiento. Se excluye al personal administrativo y asistencial, cuya vivencia laboral constituye un objeto de estudio independiente.

1.6.6. Limitaciones Metodológicas del Estudio

- **Naturaleza no probabilística del diseño:** Los hallazgos fenomenológicos no persiguen la generalización estadística numérica de frecuencias poblacionales, sino la transferibilidad conceptual contextualizada según los criterios de rigor de Guba y Lincoln (1985) [12].
- **Efecto de reactividad y pudor:** La presencia de la investigadora y el uso de grabadoras de audio podrían generar reticencia inicial en ciertos informantes quechuahablantes. Dicha limitación se mitiga mediante una inmersión prolongada en el campo, el establecimiento de rapport empático y el diálogo en su lengua materna.
- **Condicionamiento biometeorológico:** Las variaciones estacionales de frío y lluvia pueden modular la vivencia somática, lo que demanda registrar notas de campo reflexivas precisas en cada sesión de entrevista.

—

1.7. Viabilidad y Consideraciones Bioéticas

La presente investigación es plenamente viable puesto que cuenta con acceso institucional favorable a las instalaciones del Centro de Salud Belén, disponibilidad de recursos humanos calificados, respaldo académico tutorial de la cátedra de EN 486 (Dr.

Manglio Aguirre Andrade) y financiamiento asegurado en su totalidad con recursos propios de la investigadora principal.

En estricta observancia del rigor bioético, el protocolo será sometido al Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) y coordinado formalmente con la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho y la Red de Salud Huamanga antes de cualquier abordaje de campo.

El estudio se rige bajo los principios de la Declaración de Helsinki (2013) [32], las pautas internacionales del CIOMS (2016) [33] y el Informe Belmont:

- **Principio de Autonomía:** Se garantizará la voluntariedad absoluta a través de la suscripción formal del Consentimiento Informado (Anexo 4), explicándose de forma detallada y comprensible la naturaleza de la investigación en quechua chanka o castellano.
- **Principio de Beneficencia y No Maleficencia:** Se asegurará un ambiente de escucha digno y contenedor, evitando cualquier revictimización o angustia emocional durante el relato vivencial. Las entrevistas podrán suspenderse si el informante lo solicita.
- **Principio de Justicia y Confidencialidad:** Se mantendrá el anonimato absoluto mediante el uso de códigos alfanuméricos despersonalizados (ejemplo: Informante 01 – [INF-01-MED]) en todas las etapas de transcripción, categorización en ATLAS.ti v9 y redacción del informe final.

2. MARCO CONTEXTUAL

En la investigación cualitativa bajo el diseño fenomenológico, el marco contextual no se reduce a una enumeración estática de datos cuantitativos ni a un inventario geográfico desvinculado; constituye la reconstrucción densa, profunda y holística del *ambiente natural* donde transcurre la vida cotidiana de las personas y donde se gesta el fenómeno estudiado [13, 25]. Para comprender la esencia de la experiencia vivida (*Lebenswelt*) de los usuarios respecto al acceso y la calidad de atención en el Centro de Salud Belén, es indispensable caracterizar la atmósfera física, cultural, social y sanitaria que envuelve, condiciona y dota de sentido a sus sentires, expectativas, frustraciones y valoraciones intersubjetivas [26, 4].

2.1. Descripción geográfica, territorial y ambiental del área de estudio

La investigación se sitúa en el Centro de Salud Belén, establecimiento sanitario cabecera perteneciente a la Microrred Huamanga de la Red de Salud Huamanga, adscrito a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho. El establecimiento se localiza en el emblemático e histórico barrio de Belén, en el sector céntrico-sur del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, a una altitud oficial de 2,760 metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas de emplazamiento corresponden a los 13°09'47" de Latitud Sur y 74°13'28" de Longitud Oeste.

El territorio bajo su responsabilidad sanitaria se asienta en la subcuenca del río Alameda, dentro de la cuenca principal del valle de Huamanga. Limita por el norte con el casco monumental y urbano central de la ciudad de Huamanga; por el sur con las urbanizaciones periurbanas del distrito de San Juan Bautista; por el este con las faldas del cerro Acuchimay y el distrito de Carmen Alto; y por el oeste con la prolongación de la avenida Mariscal Cáceres y el jirón Bellido. Su orografía presenta una topografía moderadamente accidentada, con calles estrechas, empinadas y trazados coloniales que imponen un esfuerzo físico considerable a los usuarios con movilidad reducida, gestantes y personas de la tercera edad que acuden a pie.

El clima del área es templado y seco durante las horas diurnas soleadas, con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 15 °C y 22 °C. No obstante, una característica meteorológica decisiva para la experiencia del usuario radica en la marcada oscilación térmica interdiurna: durante las madrugadas andinas (entre las 4:00 a.m. y las 6:30 a.m.), el termómetro desciende habitualmente a valores de entre 5 °C y 8 °C, llegando a extremos menores en la temporada seca y de heladas (junio a agosto). Asimismo, se presenta una temporada de precipitaciones pluviales intensas entre los meses de noviembre y marzo. Esta condición ambiental no constituye un dato accesorio, sino un determinante

corpóreo directo: los usuarios que pugnan por conseguir una cita deben pernoctar a la intemperie en la vereda exterior del establecimiento expuestos al frío penetrante y a la lluvia, lo cual predispone a la fatiga somática y agrava sus dolencias de base.

En cuanto a la conectividad y accesibilidad vial, el establecimiento cuenta con acceso terrestre directo a través de arterias vehiculares pavimentadas (Jr. Bellido, Jr. Arequipa y Av. Mariscal Cáceres). El transporte urbano está garantizado mediante diversas líneas de transporte público (microbuses de las rutas 1, 3, 7 y 12), así como por una densa flota de mototaxis y taxis colectivos. A pesar de esta conectividad formal, el costo del pasaje y las barreras físicas del relieve obligan a un amplio porcentaje de familias vulnerables de sectores altos a realizar traslados peatonales de 20 a 40 minutos cargando niños en mantas tradicionales (*llicllas*) antes de la salida del sol.

2.2. Características demográficas y estructura poblacional

La jurisdicción sanitaria asignada al Centro de Salud Belén abarca una población diana proyectada de 18,450 habitantes según el Padrón Poblacional Oficial de la Red de Salud Huamanga (2025–2026). La pirámide poblacional se caracteriza por una base ensanchada en los primeros decenios de vida y una proporción creciente de personas adultas mayores, configurando un doble desafío asistencial de perfil materno-infantil y crónico-degenerativo. La distribución por etapas de vida es la siguiente:

- **Población Infantil (menores de 5 años):** Representa el 12.4% (2,288 niños), constituyendo el segmento con mayor intensidad de demanda en los consultorios preventivo-promocionales de Crecimiento y Desarrollo (CRED), tamizaje y tratamiento de anemia ferropénica, suplementación nutricional e inmunizaciones del esquema nacional regular.
- **Población Escolar y Adolescente (5 a 17 años):** Abarca el 19.6% (3,616 personas), demandantes de intervenciones de salud bucal, tamizaje visual, salud del escolar y orientación en salud sexual y reproductiva.
- **Población Joven y Adulta (18 a 59 años):** Constituye el 52.8% (9,742 personas), con un marcado predominio de mujeres en edad fértil (MEF) que acuden para control prenatal, despistaje de cáncer de cuello uterino, planificación familiar y atenciones médicas por patologías agudas.
- **Población Adulta Mayor (60 años a más):** Concentra el 15.2% (2,804 personas), un grupo en acelerado envejecimiento que presenta alta prevalencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, artrosis y secuelas osteomusculares, requiriendo un acompañamiento asistencial continuo, trato digno y accesibilidad física preferencial.

Desde la mirada fenomenológica, resalta el fenómeno de la **feminización de la demanda matutina**: más del 70 % de los usuarios que concurren a las salas de espera son mujeres. Se trata de madres de familia que acuden al cuidado y vigilancia de la salud de sus hijos menores, mujeres gestantes en controles prenatales y mujeres cuidadoras que asisten a adultos mayores dependientes. Esta dinámica impone sobre la mujer andina una sobrecarga cotidiana de roles, donde el tiempo de espera en el centro de salud compite directamente con sus jornadas de trabajo doméstico y comercial.

2.3. Características socioculturales, lingüísticas y cosmovisión andina

El entorno comunitario de Belén se distingue por una singular riqueza identitaria y una densa trama de sociabilidad popular. Históricamente, el barrio de Belén ha sido cuna de ilustres artesanos populares de Huamanga, reconocidos internacionalmente por el arte del retablo ayacuchano, la imaginería religiosa en yeso y el tallado tradicional en piedra de Huamanga. En este espacio geográfico coexisten familias tradicionales residentes desde hace generaciones con oleadas de población migrante provenientes de las zonas rurales y provincias del centro-sur ayacuchano (Víctor Fajardo, Cangallo y Vilcas Huamán), muchas de ellas asentadas a raíz de la violencia sociopolítica de las décadas pasadas.

En el plano lingüístico, el **72 % de la población usuaria es bilingüe activa en quechua chanka y castellano**. En las generaciones de adultos mayores y en mujeres migrantes de sectores periféricos, el quechua constituye la lengua materna predominante y el vehículo exclusivo para verbalizar el sufrimiento corpóreo y anímico. Para la cosmovisión andina huamanguina, los padecimientos no son meras disfunciones biológicas aisladas, sino alteraciones del equilibrio integral del ser humano con su entorno, expresadas en nociones complejas como el dolor visceral (*nanay*), el estado de enfermedad integral (*onqoy*), la tristeza y aflicción acumulada (*llakikuy*), el enfriamiento del cuerpo (*chiriyay*) o los desórdenes espirituales derivados del espanto o susto (*mancharisqa*).

Las pautas de sociabilidad comunitaria exigen de manera indeclinable la observancia de códigos éticos y de cortesía tradicionales basados en el respeto mutuo (*respetanakuy*), el saludo formal y afectuoso (*napaykuy*) y la acogida hospitalaria (*allin chaskiy*) [20]. Cuando el personal de salud —frecuentemente hispanohablante monolingüe o condicionado por la prisa protocolar— prescinde del saludo, evita el contacto visual, interrumpe el relato del usuario o emplea un léxico excesivamente tecnicista, se produce un violento quiebre comunicativo. El usuario andino interpreta esta conducta como desdén, frialdad burocrática, soberbia institucional o discriminación clasista y étnica, replegándose en el silencio (*upallay*) y perdiendo la confianza en el sistema asistencial.

En cuanto al nivel de instrucción, el 48 % de los jefes de familia cuenta con

educación secundaria completa, un 26 % posee secundaria incompleta o primaria, y un 8 % (concentrado en adultos mayores) registra analfabetismo formal o funcional. Esta realidad representa un desafío crítico para la alfabetización en salud, pues muchos usuarios no logran descifrar las recetas médicas escritas, los calendarios de citas o la señalética institucional de los consultorios, dependiendo enteramente de la orientación verbal empática que el profesional de enfermería pueda suministrarle.

2.4. Dinámica socioeconómica, vulnerabilidad y nivel de aseguramiento público

La actividad socioeconómica de los hogares usuarios del Centro de Salud Belén se inserta de manera mayoritaria en el régimen de la economía popular informal y de subsistencia diaria. La Población Económicamente Activa (PEA) labora preponderantemente en el comercio ambulatorio de verduras, frutas y alimentos preparados en el Mercado Central de Belén y su concurrida feria sabatina; en el transporte menor mediante la conducción de mototaxis; en faenas eventuales de construcción civil (albañilería y peonaje); en talleres artesanales independientes; y en el trabajo doméstico no remunerado o remunerado por jornada.

De acuerdo con los registros del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), el **68.2 % de las familias del ámbito de influencia se encuentra clasificada en situación de pobreza y pobreza extrema**. En coherencia con este perfil de precariedad material, el **94.5 % de la población usuaria se encuentra afiliada al régimen subsidiado del Seguro Integral de Salud (SIS)**.

Esta dependencia casi total del aseguramiento público estatal confiere una trascendencia vital a la gratuidad del servicio. Los usuarios acuden al centro asistencial bajo la certeza legítima de que el Estado proveerá tanto el acto médico como los medicamentos necesarios para su recuperación. Cuando la farmacia del establecimiento incurre en roturas de stock o desabastecimiento de medicamentos esenciales (como antibióticos de primera línea, antipiréticos, micronutrientes para la anemia o fármacos antihipertensivos), se suscita una crisis devastadora en la economía doméstica: el usuario se ve conminado a realizar un **gasto de bolsillo imprevisto** en las boticas y farmacias comerciales privadas que proliferan en los alrededores del centro de salud. Para una madre que vive de las ganancias del día a día en el mercado, destinar 20 o 30 soles a la compra de fármacos implica desfinanciar la alimentación diaria del hogar, vivencia que es experimentada con honda amargura, desesperanza e impotencia frente a la precariedad del sistema público.

2.5. Características sanitarias, cartera de servicios y capacidad resolutiva institucional

El Centro de Salud Belén se encuentra formalmente categorizado como un establecimiento de salud del primer nivel de atención de nivel **I-3** (sin internamiento hospitalario), desempeñando un papel neurálgico como cabecera de microred asistencial. Su misión operativa consiste en brindar atención integral ambulatoria, promocional, preventiva y de recuperación básica para descongestionar el Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena” (Nivel III-1).

A continuación se detalla la oferta prestacional y la distribución del talento humano asistencial disponible en el establecimiento:

Tabla 1: Cartera de servicios asistenciales y talento humano del Centro de Salud Belén (I-3).

Cartera de Servicios	Actividades Asistenciales Principales	Turno	Personal Asignado
Medicina General	Consulta ambulatoria, diagnóstico clínico, prescripción médica y atención de morbilidades agudas y crónicas.	Mañana / Tarde	04 Médicos Cirujanos
Enfermería (CRED e Inmunizaciones)	Control del crecimiento y desarrollo del niño, tamizaje de anemia, vacunación del esquema regular y consejería nutricional.	Mañana / Tarde	06 Lic. en Enfermería
Enfermería (TBC y No Transmisibles)	Control de tuberculosis (PCT), administración de tratamiento DOTS, tamizaje de hipertensión arterial y diabetes mellitus.	Mañana	02 Lic. en Enfermería
Obstetricia (Salud Reproductiva)	Control prenatal, psicoprofilaxis obstétrica, monitoreo fetal básico, planificación familiar y tamizaje de cáncer ginecológico.	Mañana / Tarde	04 Lic. en Obstetricia

El perfil epidemiológico de la demanda ambulatoria está hegemonizado por las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), parásitos intestinal, anemia por deficiencia de hierro en niños menores de 36 meses, infecciones del tracto urinario (ITU) en mujeres en edad fértil y gestantes, lumbalgias mecánicas derivadas del trabajo físico, y patologías crónicas no transmisibles (hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2) en adultos mayores.

No obstante su relevancia estratégica, el establecimiento enfrenta una serie de **nudos críticos institucionales y barreras operativas** que inciden directamente en la subjetividad del usuario:

1. **Mecanismo de asignación de cupos matutinos (*tickets*):** El establecimiento oferta un número restringido de atenciones médicas por turno (generalmente entre 12 y 16 cupos por consultorio médico), limitadas estrictamente a la jornada asistencial de 6 horas. Esta restricción cuantitativa obliga a los usuarios a disputarse los turnos desde tempranas horas de la madrugada, generando un clima de zozobra e incertidumbre donde muchas personas, tras aguardar horas en la fila exterior, reciben la notificación de que los cupos se han agotado.
2. **Limitaciones arquitectónicas y hacinamiento espacial:** El centro de salud funciona en un inmueble cuya infraestructura original ha sido sucesivamente adaptada, presentando pasillos estrechos, salas de espera techadas pero con escaso aislamiento térmico y bancas metálicas insuficientes. La tabiquería provisional entre consultorios adolece de aislamiento acústico, lo que provoca la filtración de conversaciones clínicas y quebranta el derecho a la privacidad e intimidad corporal y emocional de los pacientes.
3. **Inestabilidad laboral y sobrecarga burocrática:** Una fracción considerable del personal profesional y técnico se encuentra bajo regímenes de contratación temporal transitoria (CAS), lo que origina una continua rotación de profesionales que interrumpe la continuidad del vínculo afectivo con los pacientes de la comunidad. A ello se suma la sobrecarga de digitación en los sistemas informáticos (HIS-MINSA y formato FUA-SIS), la cual absorbe gran parte del tiempo de consulta, obligando al profesional a interactuar con la pantalla del computador en detrimento del contacto visual con el usuario.

2.6. Articulación dialéctica del escenario físico-social con las dimensiones existenciales del usuario (*Lebenswelt*)

En concordancia con los postulados epistemológicos de Max van Manen [26], John Creswell [25] y Roberto Hernández-Sampieri [13], el mundo de la vida (*Lebenswelt*) de

los seres humanos se articula indisolublemente a través de cuatro existenciales universales: la temporalidad, la espacialidad, la corporalidad y la relacionalidad. El marco contextual del Centro de Salud Belén no actúa como un mero telón de fondo pasivo, sino que opera como un escenario dialéctico que condiciona y da forma a cada una de estas dimensiones existenciales, tal como se sintetiza a continuación:

Tabla 2: Articulación dialéctica entre el contexto empírico de Belén y los cuatro existenciales del mundo de la vida (*Lebenswelt*).

Dimensión Existencial (<i>Lebenswelt</i>)	Manifestación Empírica en el Contexto de Belén	Significado Vivencial y Afectivo Construido por el Usuario
Temporalidad (<i>Tiempo vivido</i>)	Despertar forzado a las 4:00 a.m.; horas de vigilia en la vereda a la espera de la apertura del portón (7:00 a.m.); lapsos prolongados de espera en salas (2 a 3 horas) frente a una consulta médica de apenas 10 a 15 minutos.	Vivencia del tiempo suspendido, angustia e impotencia ante la posibilidad de perder el cupo. Disparidad percibida entre el enorme sacrificio temporal realizado y la brevedad del contacto clínico.
Espacialidad (<i>Espacio vivido</i>)	La vereda exterior pública; el portón de rejas de metal; los pasadizos estrechos abarrotados de pacientes; consultorios con paredes divisorias delgadas que dejan filtrar voces e intimididades; ventanilla de admisión con rejas o vidrio.	Sensación de hacinamiento, exposición pública y pérdida de intimidad. La ventanilla y el portón operan como fronteras físicas y simbólicas que separan al usuario del poder biomédico institucional.
Corporalidad (<i>Cuerpo vivido</i>)	Frío lacerante de la madrugada andina (5 °C a 8 °C); fatiga física muscular por permanecer de pie durante horas; hambre y sed por asistir en ayunas; llanto de los infantes acatarrados en mantas; dolores articulares intensificados por la intemperie.	El cuerpo enfermo no es un objeto abstracto: es el asiento directo de la vulnerabilidad física, el dolor y la incomodidad somática. El acto asistencial es ansiado como un alivio palpable a la opresión del cuerpo.
Relacionalidad (<i>Relación vivida con los otros</i>)	Encuentro intersubjetivo entre el usuario quechua-mestizo vulnerable y el personal sanitario; presencia del saludo cordial (<i>nipaykuy</i>) o su omisión; mirada a los ojos frente a la mirada fija en el monitor; paciencia explicativa o respuestas cortantes.	La calidad se define en la dignidad del trato interpersonal: el usuario busca acogida humana (<i>allin chaskiy</i>), respeto mutuo (<i>respetanakuy</i>) y comprensión en su propia lengua. La calidez del cuidado de enfermería transforma el desamparo en alivio y gratitud.

Esta articulación multidimensional confirma que, para el usuario del Centro de

Salud Belén, la “calidad de atención” trasciende ampliamente los parámetros gerenciales o el abastecimiento técnico; constituye una experiencia existencial totalizante donde el cuerpo aterido, el tiempo sacrificado, el espacio habitado y el trato humano recibido configuran la esencia de su satisfacción o sufrimiento frente al sistema público de salud.

3. ABORDAJE TEÓRICO

3.1. Antecedentes de estudio

En estricta observancia del estándar metodológico cualitativo y de la cátedra de EN 486 (UNSCH), a cargo del Dr. Manglio Aguirre Andrade, la revisión de la literatura se orienta a comprender cómo se ha investigado la **experiencia vivida y el significado de la calidad asistencial y del encuentro interpersonal**:

3.1.1. Antecedentes internacionales

- **Gómez-Restrepo y colaboradores (2023, Colombia):** En su investigación cualitativa fenomenológica titulada “*Experiencia del usuario sobre la calidad del trato interpersonal en el primer nivel de atención*”, analizaron 18 entrevistas en profundidad en centros de salud primarios. Concluyeron que la percepción del usuario está gobernada por la calidez comunicativa, el contacto visual y la empatía del profesional de enfermería. Demostraron que una relación de cuidado humanizada genera bienestar emocional y confianza terapéutica, independientemente de las limitaciones materiales del entorno asistencial. *Aporte al estudio:* Aporta categorías directas sobre la validación afectiva del paciente en la consulta.
- **Pérez y Silva (2022, Ecuador):** En su estudio cualitativo hermenéutico “*Significados de la relación enfermera-paciente desde la vivencia del usuario andino*”, entrevistaron a 15 usuarios quechuahablantes. Sus hallazgos revelaron que el saludo cordial en lengua originaria, el tono de voz pausado y la escucha libre de juicios son interpretados por los usuarios como los máximos indicadores de dignidad y respeto profesional. *Aporte al estudio:* Provee sustento epistemológico para incorporar la pertinencia quechua chanka en el protocolo de contacto.
- **Martínez-Salazar y Morales (2021, México):** En su investigación cualitativa “*Humanización del cuidado y relación interpersonal en la consulta ambulatoria*”, desarrollada con 20 usuarios en centros comunitarios, identificaron que el uso de tecnicismos incomprensibles y la prisa del profesional provocan sentimientos de intimidación y silencio en el paciente, impidiéndole manifestar sus verdaderos temores. *Aporte al estudio:* Justifica la exploración de la pedagogía comunicativa del personal de salud.

3.1.2. Antecedentes nacionales

- **Mamani y Quispe (2024, Lima):** En su investigación cualitativa “*Percepción del trato humanizado en el cuidado de enfermería en el primer nivel de atención*”, determinaron mediante 16 relatos vivenciales que la frialdad en la mirada, la falta de saludo inicial y las distracciones del personal durante la consulta son valoradas por el usuario como una despersonalización del acto de cuidado. *Aporte al estudio:* Establece pautas para auditar los distractores y la presencia atenta del profesional en el consultorio.
- **Córdova y Reyes (2023, Arequipa):** En su estudio cualitativo “*Empatía, comunicación y percepción del cuidado en la atención primaria*”, concluyeron que la experiencia del usuario se transforma positivamente cuando la enfermera o médico dedican tiempo a indagar por el estado emocional del paciente y no únicamente por sus síntomas biológicos. *Aporte al estudio:* Fundamenta la subcategoría de contención afectiva y empatía.

3.1.3. Antecedentes regionales y locales (UNSCH – Ayacucho)

- **Velarde Quispedina (2023, Ayacucho – UNSCH):** En su investigación sobre la atención asistencial en Huamanga [21], evidenció que el encuentro interpersonal y el trato brindado por enfermería constituyen el núcleo vivencial determinante del bienestar del paciente, superando con creces la relevancia de las condiciones materiales y edilicias del entorno. *Aporte al estudio:* Evidencia regional sobre la primacía ontológica del trato humano frente al espacio físico.
- **Ruiz (2024, Ayacucho – UNSCH):** En su investigación en el Hospital de Apoyo de Huanta [23], comprobó que la empatía y la cohesión interna del equipo asistencial se proyectan de manera directa en la calidez, la paciencia y el respeto brindado al usuario externo. *Aporte al estudio:* Sustenta la articulación entre la actitud del profesional y la vivencia sentida del usuario.
- **Aguirre-Andrade y colaboradores (2020, Ayacucho – UNSCH):** En su estudio científico en comunidades de Cangallo [20], demostraron que la interacción asistencial en lengua originaria (quechua) y el respeto irrestricto a la cosmovisión andina son factores insustituibles para el éxito del cuidado comunitario. *Aporte al estudio:* Consolida el pilar de adecuación intercultural en la interacción del cuidado.

3.2. Bases teóricas fundamentales

3.2.1. *Dimensión del Proceso Interpersonal en la Teoría de Avedis Donabedian*

En el modelo conceptual de Avedis Donabedian [5, 6], la calidad asistencial comprende tres esferas: Estructura, Proceso y Resultado. El presente estudio adopta como fundamento cualitativo central el **Componente de Proceso en su vertiente interpersonal**:

“El manejo de la relación interpersonal es el vehículo a través del cual la atención técnica se aplica y se hace efectiva. Comprende la calidez, la empatía, el respeto a la dignidad del paciente, la privacidad, la comunicación clara y la ética demostrada en el contacto directo” [6].

Donabedian enfatiza que la pericia técnica carece de impacto terapéutico pleno si el acto de interacción fractura la confianza y la dignidad del usuario.

3.2.2. *Teoría del Cuidado Humano y Factores Caritas de Jean Watson*

La teorista Jean Watson [10] define el cuidado como el núcleo ontológico, existencial y ético de la enfermería. Postula que una atención de auténtica calidad constituye un **encuentro intersubjetivo transpersonal** guiado por los Factores Caritas:

1. Cultivo de la amabilidad, la sensibilidad y el respeto irrestricto a la dignidad humana.
2. Construcción de una relación auténtica de ayuda-confianza mediante la escucha activa y empática.
3. Aceptación incondicional de la expresión de sentimientos positivos y negativos del paciente doliente.
4. Creación de un entorno de cuidado protector que resguarde el pudor físico, mental y espiritual.

3.2.3. *Fundamentos del Cuidado Fenomenológico en Enfermería: Patricia Benner y Holly Wilson*

En concordancia con los estudios fenomenológicos empíricos en enfermería destacados por Norlyk y Harder [28] y citados por Hernández-Sampieri y Mendoza [13]:

- **Patricia Benner (2008) [29]:** Sostiene que el cuidado en enfermería es una práctica relacional, ética e intuitiva que no puede mecanizarse. En la fenomenología clínica, el profesional y el investigador comprenden que el paciente no es un obje-

to con síntomas aislados, sino un ser humano inmerso en una situación vivencial de vulnerabilidad.

- **Holly Wilson (2007) [30]:** Señala que la fenomenología empírica en salud tiene como misión develar la esencia de las vivencias del paciente, suspendiendo los presupuestos teóricos del observador para entender qué significa experimentar la atención sanitaria desde la perspectiva de quien la recibe.

3.3. Matriz de categorización cualitativa y definición de unidades de significado

De acuerdo con Roberto Hernández-Sampieri, Carlos Fernández-Collado y Pilar Baptista-Lucio (2014, Cap. 14 y 15) [13], en la investigación fenomenológica se sustituye la tradicional operacionalización positivista de variables por una **Matriz de Categorización Cualitativa**, la cual articula los conceptos potenciales de partida con las cuatro dimensiones existenciales del mundo de la vida (*Lebenswelt*) y las categorías emergentes (esenciales y divergentes):

Concepto Potencial	Dimensión Existencial	Definición Conceptual / Significado Vivencial	Categorías Emergentes y Códigos Inductivos	Pregunta Guía de Profundización
CALIDAD DE ATENCIÓN Y CUIDADO HUMANO <i>(Encuentro intersubjetivo y vivencia del usuario en el C.S. Belén)</i>	1. Temporalidad (Tiempo vivido)	Experiencia subjetiva del transcurso del tiempo: madrugar a oscuras, incertidumbre en la fila y tiempos de espera para la consulta.	• <i>Esencia compartida:</i> Madrugar a las 4:00 AM; angustia por si alcanzan cupo; sensación de tiempo detenido en sala. • <i>Variaciones individuales:</i> Percepción de mayor agilidad en CRED frente a lentitud en Medicina; jóvenes prefieren citas virtuales, adultos mayores la fila presencial.	¿Cómo vivió subjetivamente el transcurrir de las horas desde su llegada en la madrugada hasta su ingreso al consultorio?
	2. Espacialidad (Espacio vivido)	Vivencia del entorno físico, ambiental y simbólico: acera exterior, hacinamiento en pasillos, rigidez de asientos y privacidad clínica.	• <i>Esencia compartida:</i> Frío de la acera matutina; estrechez de pasillos; alivio al entrar a un ambiente reservado. • <i>Variaciones individuales:</i> Consultorios de Obstetricia percibidos con mayor reserva que Triaje; disonancia sobre la ventilación en lluvias.	¿Cómo describe el espacio físico por donde transitó? ¿Sintió que el consultorio le brindó la intimidad y tranquilidad necesaria?
	3. Corporalidad (Cuerpo vivido)	Sentires somáticos y físicos de la persona doliente: fatiga, hambre en ayunas, frío penetrante, dolor de la afección y alivio corporal.	• <i>Esencia compartida:</i> Cansancio lumbar por estar de pie; frío matutino; distensión corporal al ser atendido y recibir medicinas. • <i>Variaciones individuales:</i> Madres reportan llanto y cansancio de los niños; adultos mayores expresan dolor articular y entumecimiento.	¿Qué sensaciones experimentó en su cuerpo (dolor, fatiga, frío, alivio) a lo largo de toda su espera y atención clínica?
	4. Relacionalidad (Relación humana vivida)	Vínculo intersubjetivo entre el equipo asistencial y el usuario: saludo cálido (<i>napaykuy</i>), empatía, escucha activa y lengua quechua.	• <i>Esencia compartida:</i> Necesidad vital de calidez y mirada atenta; consuelo al ser escuchado; dignidad al comunicarse en quechua chanka. • <i>Variaciones individuales:</i> Trato cercano y paciente en Enfermería frente a mayor prisa en Medicina; quejas de indiferencia en ventanilla de Admisión.	¿Cómo fue el encuentro humano con el médico o enfermera? ¿Sintió calidez, paciencia y escucha atenta?

4. METODOLOGÍA: DISEÑO FENOMENOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN

4.1. Fundamentación filosófica y epistemológica del diseño fenomenológico

La presente investigación se inserta en el paradigma interpretativo-naturalista y adopta un **enfoque puramente cualitativo con diseño fenomenológico** (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2014, Cap. 12 y 15) [13]. Como afirman Roberto Hernández-Sampieri y colaboradores, la fenomenología no es únicamente un conjunto de técnicas procedimentales, sino simultáneamente una filosofía, una postura epistemológica y un riguroso diseño investigativo cuyo origen se remonta al pensamiento de Edmund Husserl (1859–1938) [24]. Su propósito cardinal radica en **explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un determinado fenómeno y descubrir los elementos en común (la esencia compartida) de tales vivencias** [13].

En el campo de las ciencias de la salud y el cuidado de enfermería, Norlyk y Harder [28] evaluaron 88 estudios empíricos demostrando que la fenomenología es el abordaje con mayor pertinencia ontológica para develar las vivencias subjetivas directas frente a la atención asistencial. El estudio se rige por las siguientes distinciones y premisas:

- **Diferenciación frente a la Teoría Fundamentada:** Mientras que la teoría fundamentada persigue generar un modelo teórico explicativo abstracto a partir de los datos, en el diseño fenomenológico **los investigadores trabajan directamente con las unidades o declaraciones de los participantes y sus vivencias**, explorando lo que los individuos tienen en común respecto al fenómeno, más que abstraerlas para crear un modelo hipotético impuesto [13]. Los datos provienen de sentimientos, emociones, razonamientos, percepciones y sentires somáticos (dolor, angustia, consuelo, gratitud, frialdad) [29, 13].
- **Diferenciación frente al Diseño Narrativo:** En tanto que el diseño narrativo se focaliza en la sucesión cronológica de eventos (la historia biográfica en el tiempo), el diseño fenomenológico se enfoca con exclusividad en la **esencia de la experiencia compartida** (lo que vivenciaron los participantes y de qué forma lo vivieron en su corporalidad y contexto) [13].
- **Diferenciación frente a la Etnografía y la Investigación-Acción:** No busca el estudio holístico y prolongado de una cultura comunal completa [19], ni introduce intervenciones experimentales o modificaciones deliberadas de la realidad (investigación-acción), preservando la fidelidad descriptiva e interpretativa del fenómeno tal como acontece en su estado natural.
- **Articulación de dos vertientes fenomenológicas complementarias (Sampieri**

et al., 2014):

1. *Fenomenología empírica o psicológica* [27, 25, 30]: Centrada en describir la esencia de las vivencias de los usuarios; la investigadora suspende temporalmente sus juicios previos (*epojé* o *bracketing*) para aprender de forma pura la experiencia del paciente.
2. *Fenomenología hermenéutica* [26, 25]: Orientada a la interpretación reflexiva de los discursos y de los “textos de la vida”, develando significados latentes, silencios y metáforas en quechua chanka dentro del contexto sociocultural andino de Huamanga.

4.2. Los cuatro existenciales de la experiencia humana vivida (van Manen y Sampieri)

Siguiendo las directrices de Roberto Hernández-Sampieri et al. [13] (p. 494) y Max van Manen [26], toda indagación fenomenológica exige contextualizar las experiencias humanas en torno a cuatro estructuras existenciales universales del mundo de la vida (*Lebenswelt*):

1. **Temporalidad (el tiempo vivido):** Alude a la percepción subjetiva del paso del tiempo y al momento vivencial en que acontecen los sucesos. En el Centro de Salud Belén, la temporalidad se vivencia en la vigilia del madrugar a las 4:00 AM, la incertidumbre angustiosa durante las horas en la fila exterior antes de abrir ventanilla, el tiempo detenido en las bancas de espera y la sensación de sosiego o prisa en la consulta.
2. **Espacialidad (el espacio vivido):** Comprende el entorno físico, ambiental y simbólico donde transcurre la experiencia. Abarca la intemperie gélida de la acera matutina, el hacinamiento en pasillos angostos, la incomodidad de bancas duras y la atmósfera de intimidad, calidez o invasión a la privacidad dentro del consultorio.
3. **Corporalidad (el cuerpo vivido):** Examina la dimensión física y somática de la persona que vive el fenómeno. En los usuarios de Belén, el cuerpo vivido se manifiesta a través del frío penetrante en la madrugada, el cansancio muscular por permanecer horas de pie, la fatiga del ayuno, el llanto del niño en brazos de la madre, el dolor somático que motiva la búsqueda de ayuda y el alivio físico al recibir la atención.
4. **Relacionalidad (la relación humana vivida e intersubjetividad):** El encuentro intersubjetivo que se establece entre el profesional de salud y el usuario doliente. Constituye el corazón del cuidado: el saludo afectuoso (*napaykuy*), el contacto visual sincero, la escucha atenta, la calidez o desdén burocrático, y el puente

comunicativo forjado mediante el uso fluido de la lengua originaria quechua chanka.

4.3. Postura epistemológica, reflexividad y reducción fenomenológica (*Epojé*)

En la investigación cualitativa fenomenológica, el investigador reconoce que **su propia persona actúa como el instrumento principal de indagación y contacto humano** (Hernández-Sampieri et al., 2014, Cap. 14) [13]. La investigadora adopta una postura reflexiva continua gobernada por:

1. **Práctica de la Reducción Fenomenológica (*Epojé* / *Bracketing*):** De acuerdo con Edmund Husserl [24], Clark Moustakas [27] y John Creswell [25], la investigadora realiza una suspensión consciente y sistemática de sus propios juicios previos, experiencias previas como interna de enfermería y conceptos clínicos anticipados, para aproximarse a los relatos de los usuarios con total apertura y asombro epistémico.
2. **Construcción de Clima de Confianza (*Rapport*):** Establecimiento de una relación horizontal y fraterna con los participantes. En los entornos sanitarios andinos, el informante sólo comparte sus temores profundos y sus percepciones íntimas si experimenta un trato genuinamente afectuoso y desprovisto de jerarquías institucionales.
3. **Empatía Intercultural y Sensibilidad Lingüística:** Comprensión del mundo afectivo del usuario andino desde su propia cosmovisión, interactuando en quechua chanka o castellano para que el participante se exprese con libertad, sin temor a ser juzgado o desatendido en su salud.

4.4. Muestreo cualitativo: Muestra de casos tipo, homogénea y saturación teórica

En consonancia con el Capítulo 13 de Roberto Hernández-Sampieri, Carlos Fernández-Collado y Pilar Baptista-Lucio [13], el muestreo cualitativo no persigue la representatividad matemática de una población ni el cálculo de tamaños muestrales mediante fórmulas probabilísticas; su propósito fundamental es **seleccionar casos que aporten profundidad, riqueza informativa y comprensión exhaustiva del fenómeno**:

- **Tipo de Muestra Dirigida:** Se adopta una **muestra de casos tipo y homogénea**, constituida por personas usuarias que poseen perfiles comunes y que han vivenciado de manera directa, prolongada y personal el fenómeno del acceso y la atención en el Centro de Salud Belén.
- **Principio de Saturación de Categorías:** El número definitivo de participantes

no se fija de manera rígida apriorística, sino que se define en el trabajo de campo por el principio de **saturación teórica** [31], entendido como el momento metodológico en el cual la recolección de nuevas entrevistas ya no genera propiedades, comprensiones ni categorías emergentes novedosas sobre la vivencia asistencial. Se estima preliminarmente una muestra referencial de 12 a 18 participantes informantes clave.

Criterios de Inclusión Fenomenológicos:

1. Personas usuarias mayores de 18 años, de ambos sexos, que hayan recibido atención en los consultorios de Medicina General, Enfermería (CRED, Inmunizaciones), Obstetricia u Odontología del Centro de Salud Belén en los últimos tres meses.
2. Personas que hayan vivenciado personalmente la trayectoria de acceso (madrugar, espera en salas y contacto clínico).
3. Participación voluntaria ratificada mediante la firma o huella dactilar del Consentimiento Informado (Anexo 4).
4. Capacidad de verbalizar y reflexionar sobre sus vivencias asistenciales en quechua chanka o castellano.

Criterios de Exclusión Fenomenológicos:

1. Personas con afecciones cognitivas agudas o alteraciones de la comunicación verbal que imposibiliten el relato dialógico reflexivo.
2. Usuarios que acudan únicamente a gestiones administrativas breves de ventanilla sin haber recibido atención clínica en consultorio.

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de vivencias (Sampieri, Cap. 14)

Definiendo al **investigador como el instrumento principal de recolección de los datos**, se aplican técnicas cualitativas no estandarizadas que permiten capturar el fenómeno en su ambiente natural:

1. **Entrevistas Fenomenológicas en Profundidad:** Técnica central (sesiones de 45 a 60 minutos) conducida de forma abierta y semiestructurada a través de una guía flexible (Anexo 1), orientada a profundizar en el significado, la corporalidad, el tiempo y los lazos interpersonales experimentados en el centro de salud [25, 28].
2. **Grupos de Enfoque (Focus Groups):** Encuentros colectivos dialógicos (6 a 8 usuarios por grupo) en un ambiente tranquilo cedido por el centro de salud, diseñados para confrontar, enriquecer y construir colectivamente las categorías vivenciales compartidas respecto a las filas de madrugada y el trato humano.

3. **Observación Cualitativa no Estructurada e Inmersión en el Ambiente Natural:** Presencia atenta y reflexiva de la investigadora en los escenarios naturales (la acera exterior a las 4:30 AM, los pasillos de espera, las ventanillas y el ingreso a consultorios), prestando atención a expresiones espontáneas, posturas de fatiga y dinámicas de interacción.
4. **Bitácora y Diario de Campo Reflexivo:** Instrumento fundamental donde la investigadora registra notas de campo, impresiones sensoriales, silencios, expresiones corporales, inflexiones de voz en quechua y notas de reflexividad pos-entrevista.
5. **Triangulación Múltiple (Métodos y Fuentes de Datos):** Conforme a Sampieri et al. [13] y Okuda y Gómez-Restrepo [16], se efectúa una triangulación de métodos (entrevistas en profundidad + grupos de enfoque + observación no estructurada + bitácora de campo) y una triangulación de fuentes de datos mediante tres miradas concurrentes:
 - *Usuarios pacientes dolientes:* Madres en CRED, gestantes y adultos mayores (la vivencia sentida en carne propia).
 - *Personal asistencial y de enfermería:* Quienes proveen el cuidado (retos operativos y condicionantes institucionales).
 - *Acompañantes y líderes comunitarios de Belén:* Familiares y vecinos que presencian las esperas (la mirada comunitaria colectiva).

4.6. Criterios de rigor científico cualitativo (Hernández-Sampieri, Cap. 14)

En la investigación cualitativa se reemplazan radicalmente los conceptos positivistas de validez y confiabilidad estadística por los cuatro criterios de rigor cualitativo establecidos por Roberto Hernández-Sampieri, Carlos Fernández-Collado y Pilar Baptista-Lucio [13] (articulando los postulados clásicos de Lincoln y Guba [12]):

Criterio de Rigor	Definición Metodológica (Sampieri)	Estrategia Operativa de Aseguramiento
1. Dependencia (Consistencia Cualitativa)	Coherencia interna, estabilidad y consistencia en los procedimientos de recolección y sistematización de los datos.	• Pistas de auditoría transparentes. • Registro detallado en la bitácora de campo. • Protocolo metodológico sistemático de transcripción y codificación.
2. Credibilidad (Validez Interna Cualitativa)	Fidelidad y veracidad con la que las interpretaciones y narrativas del investigador capturan los significados reales de los participantes.	• Triangulación múltiple de métodos y fuentes. • Transcripción íntegra fonética (<i>verbatim</i>). • Verificación con los participantes (<i>member checking</i> / confirmación testimonial).
3. Transferencia (Aplicabilidad Contextual)	Posibilidad de transferir o contextualizar los hallazgos a otros escenarios con características ecológicas y sociales análogas.	• Descripción densa y detallada del contexto del C.S. Belén (Capítulo II). • Caracterización sociocultural y lingüística minuciosa de los informantes.
4. Confirmabilidad (Neutralidad Reflexiva)	Garantía de que los hallazgos representan genuinamente las vivencias de los informantes y no los sesgos, prejuicios o intereses del investigador.	• Práctica sistemática de la reducción fenomenológica (<i>epojé</i> o <i>bracketing</i>). • Memos analíticos de reflexividad. • Auditoría y revisión crítica con el asesor Dr. Manglio Aguirre Andrade.

Tabla 4: Criterios de rigor científico cualitativo según Hernández-Sampieri (2014).

4.7. Procedimiento sistemático de análisis cualitativo fenomenológico (Sampieri, Cap. 14 y 15)

El análisis cualitativo se regirá por la ruta procedimental del diseño fenomenológico establecida por Roberto Hernández-Sampieri y colaboradores [13] (Capítulos 14 y 15), articulada con las directrices canónicas de Colaizzi, Moustakas [27] y Creswell [25], apoyada técnicamente mediante el software cualitativo ATLAS.ti v9:

1. Organización, transcripción y lectura holística: Preparación y digitalización

exhaustiva de los registros sonoros en transcripciones literales palabra por palabra (*verbatim*) dentro de las 24 horas posteriores a cada sesión, preservando pausas, llanto, silencios y vocablos en quechua chanka. A continuación, inmersión y lecturas repetidas del material para alcanzar una aprehensión intuitiva y holística del sentido global de los discursos.

2. **Codificación Abierta (Primer Nivel) y Horizontalización (*Horizontalization*):** Segmentación sistemática de los testimonios en unidades de análisis o de significado (frases, expresiones y párrafos relevantes). A cada unidad se le asigna igual valor epistémico inicial (horizontalización), eliminando enunciados repetitivos para identificar y codificar inductivamente las **categorías emergentes**.
3. **Codificación Axial y Selectiva (Segundo Nivel) – Esencia compartida vs. Divergencias individuales:** Agrupamiento y articulación de las categorías emergentes en temas centrales y redes semánticas complejas. En estricto cumplimiento de Hernández-Sampieri et al. [13] (p. 494), se construye la matriz dialéctica de análisis:
 - *Categorías esenciales o comunes (la esencia compartida):* Lo que todos o la mayoría de los usuarios tienen en común respecto al acceso y la calidad del trato humano.
 - *Categorías diferentes o divergentes (variaciones individuales):* Visiones disonantes, matices y discrepancias generacionales o de servicio asistencial.
4. **Contextualización Fenomenológica en el mundo de la vida (*Lebenswelt*):** Elaboración integrada de dos descripciones narrativas complementarias:
 - *Descripción Textural:* Relato exhaustivo de **lo que** experimentaron los usuarios respecto al fenómeno.
 - *Descripción Estructural:* Comprensión profunda de **cómo** vivenciaron el fenómeno en términos de las cuatro dimensiones existenciales: **temporalidad** (tiempo vivido), **espacio** (lugar vivido), **corporalidad** (cuerpo doliente vivido) y **contexto relacional** (relación interpersonal e intersubjetiva).
5. **Síntesis narrativa de la esencia y confirmación testimonial (*Member Checking*):** Redacción de la narrativa sintética final que transmite la esencia universal de la experiencia vivida, seguida de la devolución del reporte descriptivo a un grupo de informantes clave para corroborar que sus vivencias fueron capturadas con fidelidad suprema.

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1. Asignación de recursos humanos y talento investigador

El desarrollo del proyecto de investigación estará sustentado por el siguiente equipo:

- **Investigadora Principal:** Bach. Gresly Lucero Pariona Palomino, egresada de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (ORCID: 0009-0008-5421-9872). Responsable de la formulación teórica, trabajo de campo, realización de entrevistas, transcripción y redacción final de la tesis.
- **Asesor de Tesis:** Dr. Manglio Aguirre Andrade, Docente Principal y Catedrático de Proyecto de Investigación en Salud (EN 486) de la Facultad de Ciencias de la Salud – UNSCH (ORCID: 0000-0001-8234-567X). Responsable de la orientación epistemológica, auditoría metodológica, supervisión ética y validación científica del estudio.
- **Personal de Apoyo Técnico y Lingüístico (02):** Asistentes de campo egresados de Enfermería con dominio fluido y acreditado del quechua chanka, responsables de la logística, apoyo en la preparación de ambientes de entrevista y co-verificación de la fidelidad de las transcripciones fonéticas.

5.2. Presupuesto analítico y programación de gastos

El presupuesto general del proyecto ha sido proyectado a precios de mercado local en la ciudad de Ayacucho, desglosado en tres partidas presupuestarias esenciales:

5.2.1. Pago de servicios de personal

Servicios Requeridos	U.M.	Cantidad	Costo Unit. (S/.)	Total (S/.)
Asesoría temática especializada y juicio de expertos	Mes	04	500.00	2,000.00
Personal de apoyo logístico y lingüístico quechua (02)	Mes	02	500.00	1,000.00
SUBTOTAL PARTIDA 1				3,000.00

Tabla 5: Presupuesto analítico de servicios de personal.

5.2.2. Programación de otros servicios

Servicios Complementarios	U.M.	Cantidad	Costo Unit. (S/.)	Total (S/.)
Impresión de protocolos, consentimientos y guías	Hojas	1000	0.20	200.00
Conectividad y almacenamiento en la nube de audios	Horas	200	1.00	200.00
Licencia de software de análisis cualitativo (ATLAS.ti)	Unidad	01	500.00	500.00
Empastado formal de ejemplares según norma UNSCH	Unidad	05	20.00	100.00
Movilidad local y desplazamiento urbano a C.S. Belén	Días	20	10.00	200.00
SUBTOTAL PARTIDA 2				1,200.00

Tabla 6: Presupuesto analítico de otros servicios.

5.2.3. Adquisición de materiales y suministros de bioseguridad

Materiales e Insumos	U.M.	Cantidad	Costo Unit. (S/.)	Total (S/.)
Material bibliográfico normativo y libros de metodología	Unidad	02	50.00	100.00
Papel Bond A4 80 gr. para trabajo de campo y borradores	Millar	02	25.00	50.00
Memoria USB de 32 GB con cifrado de seguridad para audios	Unidad	02	40.00	80.00
Archivadores, fólderes y separadores documentarios	Unidad	10	1.00	10.00
Útiles de escritorio (lapiceros, libretas, resaltadores)	Unidad	10	2.00	20.00
Mascarillas descartables KN95 para bioseguridad	Caja	02	20.00	40.00
Alcohol medicinal en gel al 70 %	Frasco	02	10.00	20.00
Fondo de reserva para imprevistos y contingencias operativas	Global	01	80.00	80.00
SUBTOTAL PARTIDA 3				400.00

Tabla 7: Presupuesto analítico de materiales y suministros de bioseguridad.

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO: S/. 4,600.00 Soles.

5.3. Financiamiento

La ejecución integral del presente proyecto de investigación no demanda asignación presupuestaria a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga ni al Ministerio de Salud, siendo asumido al 100 % con **recursos económicos propios de la investigadora principal**.

5.4. Cronograma de actividades y dimensionamiento temporal (Técnica PERT)

Para dimensionar con rigurosidad el tiempo operativo del proyecto se aplica la técnica de evaluación y revisión de programas (PERT), calculando el tiempo esperado (t_e) mediante la formulación tripartita de estimación temporal:

$$t_e = \frac{O + 4m + P}{6} \quad (1)$$

donde O denota el tiempo optimista (4 meses), m el tiempo más probable (6 meses) y P el tiempo pesimista (10 meses), arrojando un horizonte medio de ejecución de 6.3 meses.

En estricta observancia de los lineamientos del Dr. Manglio Aguirre Andrade, la planificación administrativa pondera la realidad burocrática del trámite universitario: tras la aprobación del proyecto en aula, el dictamen ante el Comité de Ética (CIEI-UNSCH) y la emisión de la resolución decanal toman aproximadamente de tres a seis meses. Por consiguiente, la fase de ejecución empírica de campo, procesamiento e informe final se programa operativamente entre los meses de agosto de 2026 y enero de 2027:

Fases y Actividades de Investigación	Ago 2026	Set 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027
Presentación y registro formal del proyecto	X					
Dictamen del Comité Institucional de Ética (CIEI)		X				
Validación de instrumentos (Juicio de expertos)		X				
Coordinaciones institucionales con C.S. Belén			X			
Trabajo de campo: Entrevistas a profundidad y notas			X	X		
Transcripción verbatim y análisis con ATLAS.ti					X	
Validación de resultados con participantes					X	
Redacción y revisión del borrador de tesis con asesor					X	X
Sustentación formal de tesis de licenciatura						X

Tabla 8: Cronograma de actividades del proyecto de investigación (Técnica PERT).

5.5. Matriz de viabilidad institucional y gestión de riesgos operativos

Para asegurar la continuidad ininterrumpida de la investigación frente a posibles contingencias en el Centro de Salud Belén, se formula la siguiente matriz preventiva:

Riesgo Operativo	Impacto Potencial	Estrategia de Mitigación Institucional
Desconfianza o temor del usuario a represalias	Negativa a participar o respuestas evasivas por miedo a perder su atención SIS.	Explicación personalizada del Consentimiento Informado en quechua; garantía absoluta de confidencialidad y código alfanumérico.
Hacinamiento y falta de ambientes privados	Interrupciones y vulneración de la privacidad en el consultorio.	Coordinación anticipada con la Jefatura para uso de ambientes de biblioteca o telemedicina en horarios de baja afluencia.
Rotación de personal médico en el establecimiento	Dificultades para la triangulación con profesionales tratantes.	Establecimiento de nexos institucionales con la Coordinación de Enfermería y médicos permanentes de la microred.

Tabla 9: Matriz de contingencias y gestión de riesgos en campo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias

- [1] World Health Organization, OECD, The World Bank. Delivering quality health services: a global imperative for universal health coverage. Geneva: World Health Organization; 2018.
- [2] Ministerio de Salud del Perú. Política Nacional de Calidad en Salud: Documento Técnico. Lima: MINSA; 2021.
- [3] Ministerio de Salud del Perú. Líneas de Investigación en Salud al 2030: Resolución Ministerial N° 424-2025/MINSA. Lima: MINSA; 2025.
- [4] Dirección Regional de Salud de Ayacucho. Prioridades Regionales de Investigación en Salud de Ayacucho 2025–2030. Ayacucho: DIRESA Ayacucho; 2025.
- [5] Donabedian A. Explorations in Quality Assessment and Monitoring. Vol. 1: The Definition of Quality and Approaches to its Assessment. Ann Arbor (MI): Health Administration Press; 1980.
- [6] Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. 1966. *Milbank Q.* 2005;83(4):691-729.
- [7] Penchansky R, Thomas JW. The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction. *Med Care.* 1981;19(2):127-40.
- [8] Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL. SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *J Retailing.* 1988;64(1):12-40.
- [9] Ministerio de Salud del Perú. Guía técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario externo en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo: Resolución Ministerial N° 527-2011/MINSA. Lima: MINSA; 2011.
- [10] Watson J. Nursing: The philosophy and science of caring. 2nd ed. Boulder: University Press of Colorado; 2008.
- [11] Bunge M. La ciencia, su método y su filosofía. Buenos Aires: Editorial Sudamericana; 2014.
- [12] Lincoln YS, Guba EG. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills (CA): SAGE Publications; 1985.

- [13] Hernández-Sampieri R, Mendoza CP. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Ciudad de México: McGraw-Hill; 2018.
- [14] Katayama Omura RJ. Introducción a la investigación cualitativa: fundamentos, métodos, estrategias y técnicas. Lima: Fondo Editorial UIGV; 2014.
- [15] Pineda EB, De Alvarado EL, De Canales FH. Metodología de la investigación: manual para el desarrollo de personal de salud. 2da ed. Washington D.C.: OPS/OMS; 1994.
- [16] Okuda Benavides M, Gómez-Restrepo C. Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Rev Colomb Psiquiatr.* 2005;34(1):118-24.
- [17] Quintana L, Hermida J. La hermenéutica como método de interpretación de textos en la investigación psicoanalítica. *Rev Psicolog Cienc Afines.* 2019;16(2):73-80.
- [18] Montes-Sosa G, Castillo-Sanguino N. El método fenomenológico en la investigación educativa. *Diálogos sobre educ.* 2024;15(29):1-15.
- [19] Cotán Fernández A. El método etnográfico como construcción de conocimiento. *MÁRGENES.* 2020;1(1):83-103.
- [20] Aguirre-Andrade M, Tenorio-Acosta I, Rivas-Díaz L, Valenzuela-Oré F, Sánchez-Simbrón M, Quino-Huamaní F. Promoción de salud y nivel de salubridad de las familias, en comunidades del Distrito de Cangallo, Ayacucho 2020. *Rev Investig Salud.* 2020;14(2):45-58.
- [21] Velarde Quispedina M. Calidad de atención y satisfacción del paciente en el servicio de emergencia del Hospital Regional de Ayacucho [Tesis de Licenciatura]. Ayacucho: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 2023.
- [22] Ascama Calderón C. Factores asociados a las reacciones adversas de la vacuna contra la COVID-19 en el personal de salud de Huamanga [Tesis de Licenciatura]. Ayacucho: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 2022.
- [23] Ruiz FL. Liderazgo del profesional de enfermería y satisfacción laboral en el Hospital de Apoyo de Huanta [Tesis de Licenciatura]. Ayacucho: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 2024.
- [24] Husserl E. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Gaos J, traductor. México D.F.: Fondo de Cultura Económica; 1949.
- [25] Creswell JW. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. 3rd ed. Thousand Oaks (CA): SAGE Publications; 2013.

- [26] van Manen M. Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. Albany (NY): State University of New York Press; 1990.
- [27] Moustakas C. Phenomenological research methods. Thousand Oaks (CA): SAGE Publications; 1994.
- [28] Norlyk A, Harder I. What makes a phenomenological study phenomenological? An analysis of peer-reviewed empirical nursing studies. Qual Health Res. 2010;20(3):420-31.
- [29] Benner P. From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice. Commemorative ed. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall; 2008.
- [30] Wilson HS. Research in nursing. 3rd ed. Redwood City (CA): Addison-Wesley; 2007.
- [31] Esbensen BA, Swane CE, Hallberg IR, Thome B. Being a next of kin to an elderly person with cancer: Experiences of the relationship to the person with cancer and to the health care system. Eur J Oncol Nurs. 2008;12(1):40-8.
- [32] Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki de la AMM: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Ferney-Voltaire: WMA; 2013.
- [33] Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. Ginebra: CIOMS; 2016.

ANEXOS

Anexo 1: Guía de Entrevista a Profundidad Fenomenológica Semiestructurada Bilingüe

Título de la investigación: Percepción de la calidad de atención en usuarios del Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.

Investigadora: Gresly Lucero Pariona Palomino | **Asesor:** Dr. Manglio Aguirre Andrade.

Propósito cualitativo: Explorar, describir y comprender la esencia de la experiencia vivida (*vivencias*) por el usuario respecto al acceso y la calidad del trato humano y cuidado en el Centro de Salud Belén.

I. Ficha de Caracterización del Informante Clave (Muestra de Casos Tipo):

- Código del participante: _____ | Fecha: _____ | Hora inicio/fin: _____
- Edad: ____ años | Sexo: [] Femenino [] Masculino
- Procedencia (Barrio / Sector): _____ | Tiempo viviendo en Huamanga: _____
- Idioma materno: [] Quechua chanka [] Castellano [] Bilingüe
- Nivel de instrucción: [] Sin instrucción [] Primaria [] Secundaria [] Superior
- Ocupación principal: _____ | Tipo de seguro: [] SIS subsidiado [] Otro
- Servicio asistencial donde recibió atención hoy: [] Medicina [] CRED [] Inmunizaciones [] Obstetricia [] Odontología

II. Preguntas de Apertura y Clima de Confianza (*Rapport* y *Napaykuy*):

1. ¿Podría relatarme qué motivo de salud le motivó a acudir hoy al Centro de Salud Belén y cómo se sentía anímicamente antes de ingresar al consultorio?
En quechua chanka: ¿Imataq qamta sasachasunki mamay/taytay, imaynam sonqoyki kachkarqa doctorman manaraq yaykuchkaspayki?
2. ¿Es la primera vez que se atiende en este establecimiento o suele venir frecuentemente a este servicio?
En quechua chanka: ¿Qallariykutichu kay Centro de Saludpi atendichikunki, icha sapa kutichu hamunki?

III. Preguntas por Dimensiones Existenciales Fenomenológicas (van Manen y Samperi):

■ Dimensión Existencial 1: Temporalidad (El tiempo vivido)

3. ¿A qué hora tuvo que salir de su casa y a qué hora llegó a la fila para alcanzar un cupo? ¿Cómo vivió subjetivamente el transcurrir de las horas en la espera de la madrugada hasta culminar su atención?

En quechua chanka: ¿Ima oratataq wasikimanta lloqsimurqanki hinaspa ima oratataq chayamurqanki colaman cupota aypanaykipaq? ¿Imaynatam unay tiempota suyaspayki sientekurqanki lloqsinyakikama?

■ Dimensión Existencial 2: Espacialidad (El espacio vivido)

4. ¿Cómo describe los espacios por donde transitó (la acera exterior a oscuras, la estrechez de los pasillos, las bancas de espera y el consultorio)? ¿Sintió que el ambiente de la consulta le brindó privacidad y tranquilidad?

En quechua chanka: ¿Imaynatam suyana sitiota qawarqanki (tutayaqpi calleta, pasadizokunata, bancakunata)? ¿Consultoriopi hawka kaytachu hinaspa secretotachu sientekurqanki rimanaykipaq?

■ Dimensión Existencial 3: Corporalidad (El cuerpo vivido)

5. A lo largo de la madrugada y durante la consulta, ¿qué sensaciones experimentó físicamente su cuerpo (el frío penetrante, el dolor de su dolencia, el cansancio por estar de pie, o el alivio al ser atendido)?

En quechua chanka: ¿Suyasqayki horapi, imaynam cuerpayki sientekurqa (chiriwan, nanaywan, sayasqa shaykuywan, icha doctorta rikuspa hawkayaywan)?

■ Dimensión Existencial 4: Relacionalidad (La relación humana vivida e intersubjetividad)

6. ¿Cómo fue el encuentro humano con el médico, la enfermera o el personal de ventanilla? ¿Sintió calidez en la mirada, paciencia y escucha atenta? ¿Le hablaron en quechua chanka cuando usted lo requirió?

En quechua chanka: ¿Imaynam runa kayninkuwan chaskisurqanki doctor o enfermera? ¿Kuyakuywanchu qawasurqanki, pacienciawanchu uyarirqasunki? ¿Runasimipichu rimapayasurqanki mañakuptiki?

■ Dimensión 5: Síntesis de la Esencia y Significado Holístico del Cuidado Humano

7. Al reflexionar sobre toda su experiencia, ¿qué significa para usted recibir una atención de auténtica calidad y dignidad, y qué propondría para humanizar el cuidado en el Centro de Salud Belén?

En quechua chanka: ¿Tukuy kaykunata yuyarispá, imataq qampan allin digno atención kanman? ¿Imatataq mañakuwaq Centro de Saludpi aswan kuyakuywan atiendenankupaq?

Anexo 2: Matriz de Consistencia Fenomenológica Cualitativa

Título: PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD BELÉN, AYACUCHO 2026.

Problema Fenomenológico	Objetivos Cualitativos	Preguntas Norteadoras	Dimensiones Existentes	Metodología Cualitativa
General: ¿Cuál es el significado, la estructura y la esencia de la experiencia vivida por los usuarios respecto al fenómeno del acceso y la calidad de atención en el C.S. Belén, Ayacucho 2026?	General: Comprender y profundizar en el significado, estructura y esencia de la vivencia de los usuarios en torno al acceso y la calidad de atención en el C.S. Belén, Ayacucho 2026.	1. Temporalidad (tiempo vivido en madrugadas y esperas). 2. Espacialidad (espacio vivido en aceras, pasillos y consulta). 3. Corporalidad (cuerpo vivido, frío, fatiga somática y dolor). 4. Relacionalidad (vínculo humano, empatía y quechua chanka). 5. Esencia compartida y variaciones individuales de la calidad.	Concepto Potencial: Calidad de Atención y Cuidado Humano. Dimensiones del Lebenswelt: • D1: Temporalidad • D2: Espacialidad • D3: Corporalidad • D4: Relacionalidad • D5: Esencia del Cuidado	Paradigma: Interpretativo-naturalista. Enfoque y Diseño: Cualitativo fenomenológico empírico y hermenéutico (Sampieri, Husserl, van Manen). Muestra: Dirigida de casos tipo y homogénea. Saturación de categorías (12-18 informantes clave). Técnicas: Entrevista fenomenológica en profundidad, grupos de enfoque, observación no estructurada y bitácora. Análisis: 5 etapas (Organización, Codificación abierta, axial, selectiva, contextualización existencial y ATLAS.ti v9).

Tabla 10: Matriz de consistencia cualitativa fenomenológica según Hernández-Sampieri.

Anexo 3: Formato de Validación Cualitativa por Juicio de Expertos

I. ASPECTOS GENERALES:

- 1.1. Apellidos y nombres del informante (Experto): _____
- 1.2. Grado académico del experto: _____
- 1.3. Profesión del experto: _____
- 1.4. Institución donde labora: _____
- 1.5. Cargo que desempeña: _____
- 1.6. Denominación del instrumento: Guía de entrevista a profundidad fenomenológica semiestructurada bilingüe.
- 1.7. Autora del instrumento: Gresly Lucero Pariona Palomino.
- 1.8. Título de la tesis: Percepción de la calidad de atención en usuarios del Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.

II. CRITERIOS DE RIGOR Y VALIDACIÓN CUALITATIVA (SAMPIERI, 2014):

Criterios	Indicadores de Evaluación Cualitativa	Sí	No	Observaciones
1. Claridad dialógica	Preguntas formuladas con lenguaje coloquial, abierto y comprensible para el usuario andino.	[]	[]	
2. Pertinencia lingüística	Preguntas en quechua chan-ka gramaticalmente naturales, afectuosas y culturalmente pertinentes.	[]	[]	
3. Consistencia fenomenológica	Articulación rigurosa con los cuatro existenciales del mundo de la vida (van Manen y Sampieri).	[]	[]	
4. Coherencia vivencial	Correspondencia simétrica entre las preguntas y la captura de la esencia y las divergencias vivenciales.	[]	[]	
5. Relevancia del cuidado	Explora estrictamente la interacción humana, los sentires corporales y la dignidad del cuidado.	[]	[]	
6. Capacidad de saturación	Capacidad inductora de las preguntas para suscitar relatos densos y alcanzar la saturación de categorías.	[]	[]	

Tabla 11: Ficha técnica de validación cualitativa por juicio de expertos.

Observaciones generales:

Ayacucho, ____ de ____ del 2026.

FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO

Anexo 4: Consentimiento Informado para Participantes Informantes Clave

Yo, _____, identificado con DNI N° _____, domiciliado en _____, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga.

He sido invitado(a) a participar de manera libre y voluntaria en la investigación titulada: **“PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD BELÉN, AYACUCHO 2026”**, desarrollada por la bachiller Gresly Lucero Pariona Palomino, bajo la asesoría del Dr. Manglio Aguirre Andrade de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH).

Declaro que se me han brindado las siguientes garantías de forma clara en mi idioma materno:

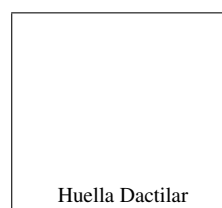
1. Mi participación consistirá en compartir mis experiencias y sentires personales mediante una entrevista dialógica.
2. La sesión será grabada únicamente en audio con fines de transcripción fidedigna.
3. Mi identidad se mantendrá en estricta reserva y anonimato mediante el empleo de un código alfanumérico confidencial.
4. Mi participación es 100 % voluntaria; puedo suspender la entrevista o retirarme del estudio en el momento que desee sin que ello perjudique en absoluto la atención médica que recibo en el establecimiento.

En señal de plena conformidad, suscribo el presente documento y estampo mi huella dactilar.

Ayacucho, ____ de _____ del 2026.

Firma del Participante Informante

DNI N°: _____



Huella Dactilar

Anexo 5: Carta de Aceptación y Asesoría Formal del Proyecto de Tesis

Ayacucho, 15 de enero del 2026.

Dr. Alejandro Yarlequé Mujica

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Asunto: Aceptación y Compromiso de Asesoría de Proyecto de Tesis Cualitativo

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho para hacer de su conocimiento que he aceptado formalmente brindar la asesoría académica y metodológica al Proyecto de Tesis con enfoque cualitativo y diseño fenomenológico titulado:

“PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD BELÉN, AYACUCHO 2026”

presentado por la egresada **Gresly Lucero Pariona Palomino**, para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería, en el marco de la cátedra de Proyecto de Investigación en Salud (EN 486).

Dicha labor de asesoría se desarrollará garantizando el más riguroso estándar científico y bioético durante las fases de formulación, dictamen ético, inmersión en campo, análisis fenomenológico, redacción del informe final y sustentación pública.

Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi especial estima personal.

Atentamente,

Dr. Manglio Aguirre Andrade

Docente de la Facultad de Ciencias de la Salud – UNSCH

ORCID: 0000-0001-8234-567X | DNI: _____